

排尿性膀胱尿道造影 (VCUG)

WARWIKI

患者须知 · 了解膀胱及尿道 X 线检查的注意事项

排尿性膀胱尿道造影（VCUG）是一种 X 线检查，在向膀胱注入造影剂后拍摄膀胱和尿道的影像，并在您排尿时同步录像。它可显示膀胱充盈和排空的过程，帮助医疗团队发现尿液向肾脏反流、狭窄或漏尿等问题。

关于这项检查

膀胱储存尿液，尿道负责将尿液排出体外。VCUG 向膀胱注入在 X 线下显影为白色的造影剂，并在排尿过程中拍摄影像。由于能捕捉膀胱和尿道的动态过程，它可发现静态影像无法显示的问题。

医疗团队可能建议您进行 VCUG 以：

- 观察膀胱充盈和排空情况
- 检查尿液是否向肾脏反流（膀胱输尿管反流）
- 在排尿时观察膀胱颈和尿道
- 发现狭窄、漏尿或憩室
- 评估膀胱、前列腺或尿道手术后的愈合情况

该检查针对下尿路（膀胱和尿道），目的是为诊断提供依据，而非治疗。

安全吗？

安全。VCUG 是常见的低风险检查，X 线剂量很小，造影剂随尿液排出体外。最常见的问题是导尿管引起的轻微尿路感染，因此操作时采用清洁技术，必要时会预防性使用抗生素。检查后可能出现短暂不适、轻度灼热感或少量血尿，通常轻微且很快消退。

名词解释

膀胱

储存尿液、等待排出的器官。

尿道

将尿液从膀胱输送到体外的管道。

导尿管

用于引流或充盈膀胱的细软管。造影剂可通过已有的导尿管注入，也可在检查时经尿道临时置管。

耻骨上膀胱造瘘管（SPT）

从下腹部小切口引流膀胱的导管，而非经尿道。若您已有此管，可用于注入造影剂。

造影剂

一种在 X 线下显示为白色的液体，使膀胱和尿道清晰可见。

排尿（排空）

将膀胱中的尿液排出。关键影像在排尿时拍摄。

反流

尿液从膀胱逆流回肾脏。VCUG 可显示这一现象。

透视

一种实时显示造影剂流动的动态 X 线技术。

排尿后影像

排尿后拍摄的影像，用于评估膀胱排空程度。

会疼吗？ 若您已有导尿管或耻骨上膀胱造瘘管，造影剂直接从中注入，无需另置新管。否则需先经尿道置入细导尿管，过程中可能感到短暂压迫或刺痛。检查时被要求排尿属正常流程。整个检查约 30 分钟。

如何准备（检查前）

准备工作很少。通常情况下：

- 若您已有**导尿管或耻骨上膀胱造瘘管**，请保留原管—通常直接用于充盈膀胱，无需另置新管。
- 可**正常饮食**，并按时服用**日常药物**，除非医疗团队另有交代。
- 多数成人检查无需镇静，通常可**自驾车回家**。

请提前告知医疗团队，若您：

- 曾对 X 线造影剂或碘过敏
- 正在服用抗凝血药
- **可能怀孕**—孕期通常避免 X 线检查
- 有尿路感染迹象（灼热感、发热或尿液浑浊、气味重）—活动性感染可能需要推迟检查

您可能需要提供**尿液样本**以排查感染，并可能在检查前后服用**抗生素**以降低感染风险。

检查过程

- 1 您躺在 X 线检查台上。
- 2 **将造影剂注入膀胱。**若您已有**耻骨上膀胱造瘘管或导尿管**，直接经原管注入—**无需另置新管**。若无，则经尿道置入细导尿管。
- 3 造影剂通过导管缓慢注入膀胱，您会感到逐渐充盈感，类似尿急。充盈过程中同步拍摄影像。
- 4 膀胱充盈后，医生会请您**排尿，同时录制 X 线影像**—这是检查最重要的环节。经尿道导管通常在此前撤除；耻骨上膀胱造瘘管可能短暂夹闭。
- 5 排尿结束后可能拍摄一张后续影像，评估膀胱排空效果。

之后

- 通常可立即回家，**恢复正常活动**。
- 排尿时可能有**轻度灼热感**，或出现少量**血尿或尿液呈淡红色**，持续一天左右—多喝水有助于缓解。
- 若您有**导尿管或耻骨上膀胱造瘘管**，医疗团队会告知护理方法。造影剂会在数小时内随尿液排出。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战
- 排尿困难或完全无法排尿
- 大量出血或出血不止
- 疼痛持续加重

需要记住的三件事

1. VCUG 是安全的 X 线检查，向膀胱注入造影剂并在排尿时录像，可显示膀胱和尿道的功能，发现反流等问题。
2. 准备简单：正常饮食，按时服药，但请告知医疗团队造影剂过敏史、抗凝药使用、可能怀孕或尿路感染症状。
3. 造影剂经已有的导管（导尿管或耻骨上膀胱造瘘管）注入，或临时置管；排尿时同步录像。检查后轻度灼热或少量血尿属正常，多喝水；若出现发热、大量出血或排尿困难，请立即就医。